Gestión de la salud pública en perspectiva comparada.
Una mirada al Modelo de Atención Primaria de la Salud (APS) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires frente a experiencias internacionales: San Pablo, Londres y Madrid

- Autores: Bottino Cané, Nicolás; Cacheiro, Laura; Ratti, Tomás
- Tutores: Cejas, Margarita; Ferrante Daniel

- Grupo: 2025-MS-AR-22
- Artículo de investigación
- Entrega N° 05
- 15/12/2025

-RH-
Programa de Especialistas Profesionales
MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS

ÍNDICE

- Introducción 4
- Metodología 6
- Estado del arte 8
- Marco teórico 10
- Resultados y análisis comparativo 14
- Conclusiones y recomendaciones 18
- Bibliografía 24
- Anexo I 23
- Anexo II 26

Gestión de la salud pública en perspectiva comparada: una mirada al Modelo de Atención Primaria de la Salud (APS) en la Ciudad de Buenos Aires frente a experiencias internacionales: San Pablo, Londres y Madrid.

Palabras claves: atención primaria de la salud; salud pública, gestión pública, análisis comparado.
Keywords: primary health care; public health, public management, comparative analysis.

Resumen:

Esta investigación analizó comparativamente los modelos públicos de Atención Primaria de la Salud (APS) de São Paulo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Madrid y Londres, con el fin de identificar diferencias estructurales en la organización territorial, el acceso, la disponibilidad de recursos y la atención a poblaciones vulnerables, especialmente migrantes. Se examinó la canasta básica de servicios, el recorrido del paciente, la conformación de equipos interdisciplinarios y las condiciones de accesibilidad geográfica y administrativa. La hipótesis sostuvo que los modelos con redes territoriales amplias, recursos asignados según necesidades y equipos estables tendieron a favorecer mayor equidad en el acceso, mientras que aquellos más orientados a la eficiencia administrativa mejoraron la gestión, pero no siempre redujeron desigualdades. El estudio se centró exclusivamente en sistemas públicos de APS, considerando su papel clave en la garantía del derecho a la salud en contextos urbanos complejos.

1. INTRODUCCIÓN

La Atención Primaria de la Salud (APS) se reconoció internacionalmente como el eje estructurante de los sistemas sanitarios orientados a la equidad, la integralidad y la eficiencia. En los contextos urbanos contemporáneos, caracterizados por una alta densidad poblacional, fuertes desigualdades socioeconómicas y una creciente diversidad cultural, el fortalecimiento de la APS se volvió un componente clave para la garantía del acceso universal a la salud. En este marco, la presente investigación analizó comparativamente los modelos públicos de APS de cuatro grandes ciudades —São Paulo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Londres y Madrid— con el propósito de comprender sus configuraciones institucionales, sus alcances y sus limitaciones.

La selección de estas ciudades respondió a su relevancia demográfica, a su condición de centros administrativos de sus respectivos países y a la diversidad de sus modelos sanitarios. Esta variedad permitió observar contrastes en la organización del primer nivel de atención, en la extensión territorial de los sistemas, en los mecanismos de acceso y continuidad de cuidados, así como en la capacidad de respuesta frente a poblaciones vulnerables, especialmente migrantes.

El análisis se estructuró a partir de una perspectiva comparativa que buscó identificar fortalezas, debilidades y aprendizajes transferibles entre sistemas. Asimismo, se examinó cómo cada modelo definió su canasta básica de servicios, cómo organizó el recorrido del paciente (patient pathway), qué estrategias desarrolló para garantizar accesibilidad administrativa y geográfica, y de qué manera abordó la atención de poblaciones con menor inserción social.

Para el desarrollo del informe nos basamos en el siguiente objetivo general y consiguientes objetivos específicos:

Objetivo general:

- Realizar un análisis comparativo cuali-cuantitativo de los sistemas públicos de APS en cuatro ciudades globales —São Paulo, CABA, Londres y Madrid—, con el fin de identificar fortalezas, desafíos y aprendizajes que contribuyan al diseño de políticas sanitarias más equitativas, integrales y eficaces.

Objetivos específicos:

- Examinar la canasta básica de servicios que conforman la oferta pública de APS en cada ciudad, considerando su alcance, integralidad y orientación preventiva.
- Analizar el recorrido del paciente (patient pathway) desde el primer contacto con el sistema de salud hasta la resolución del problema o su derivación, identificando mecanismos de acceso y continuidad.
- Comparar las estrategias de acceso y cobertura sanitaria destinadas a poblaciones migrantes, tanto regulares como en situación irregular.
- Evaluar la disponibilidad, formación y distribución de profesionales especializados en medicina general, familiar o comunitaria, así como su inserción en los equipos de APS. Identificar barreras estructurales o normativas que dificultan el acceso efectivo a la APS en contextos urbanos de alta complejidad social y demográfica.
- Sistematizar buenas prácticas y lecciones aprendidas que puedan ser transferidas o adaptadas a otros sistemas públicos de salud, especialmente en América Latina.

Asimismo, algunas de las preguntas que guiaron este informe fueron las siguientes:

- ¿Qué nivel de cobertura poblacional alcanza cada modelo de APS y cómo se distribuye territorialmente?
- ¿Cómo se componen los equipos interdisciplinarios en cada ciudad y cuál es su estabilidad laboral y funcional?
- ¿La asignación de recursos en cada sistema de APS se ajusta a las necesidades sociales y epidemiológicas de la población que atiende?
- ¿Qué mecanismos garantizan (o limitan) la accesibilidad geográfica y administrativa a los servicios de APS?
- ¿Qué diferencias existen en la canasta básica de servicios ofrecidos por cada modelo y cómo influyen en la equidad de acceso?
- ¿Cómo se relaciona el presupuesto destinado a APS con su capacidad resolutiva y cobertura efectiva?

- ¿Qué impacto tienen los modelos de APS analizados en la reducción de desigualdades de acceso entre distintos grupos sociales, incluyendo población migrante y sectores en situación de vulnerabilidad?

La hipótesis que orientó la investigación sostuvo que los modelos de APS que articularon una red territorial amplia, equipos estables y recursos asignados en función de las necesidades sociales tendieron a promover mayor equidad en el acceso a la salud. En cambio, aquellos enfoques centrados predominantemente en la eficiencia administrativa y la contención del gasto pudieron mejorar la gestión, pero no necesariamente redujeron las brechas en el acceso. Por tanto, este informe se propuso analizar y comparar exclusivamente los sistemas públicos de APS de São Paulo, CABA, Londres y Madrid, sin incluir el sector privado ni los esquemas de financiamiento.

METODOLOGÍA

La investigación adoptó un enfoque mixto de carácter cuali-cuantitativo, con un diseño comparativo y exploratorio. Este enfoque permitió analizar tanto las estructuras institucionales de los sistemas públicos de Atención Primaria de la Salud (APS) como los resultados y dinámicas concretas de acceso que emergieron de su funcionamiento. El estudio se centró en cuatro ciudades globales —São Paulo, CABA, Madrid y Londres— seleccionadas por su relevancia demográfica, su diversidad organizacional y la disponibilidad de documentación pública y académica.

Enfoque general y criterios de comparación

En primer lugar, se definieron cinco ejes iniciales para orientar el análisis:

1. tipo y cantidad de población atendida;
2. disponibilidad y distribución de efectores;
3. organización por niveles de complejidad;
4. factores ambientales y climáticos;
5. accesibilidad en sus distintas dimensiones.

Sin embargo, a medida que avanzó el relevamiento empírico, estas variables fueron reorganizadas en tres grandes categorías analíticas, lo que permitió una lectura más sistemática y comparativa entre las ciudades:

- A. Contexto y población atendida
- B. Recursos y organización del sistema
- C. Acceso y desempeño de la APS.

Esta clasificación estructuró tanto el proceso de sistematización como el análisis final.

Enfoque cualitativo

El componente cualitativo se basó en un análisis documental exhaustivo. Se revisaron y sistematizaron fuentes primarias y secundarias, entre ellas:

- normativas, planes estratégicos y documentación técnica de los organismos de salud de cada ciudad;
- informes de organismos internacionales como la OMS y la OPS;
- evaluaciones de políticas públicas;
- literatura académica especializada (artículos, libros, revisiones sistemáticas);
- reportes institucionales, documentos de gestión y materiales oficiales disponibles en portales de datos abiertos.

Este enfoque permitió reconstruir los modelos organizativos de APS, las trayectorias históricas de cada sistema, el diseño de las canastas básicas de servicios y las estrategias destinadas a la atención de poblaciones en situación de vulnerabilidad social, incluyendo migrantes y habitantes de zonas urbanas excluidas.

Enfoque cuantitativo

El componente cuantitativo se sustentó en la recopilación y análisis de datos estadísticos secundarios provenientes de fuentes oficiales y confiables. Entre estas se incluyeron:

- bases de datos de la OMS y OPS;
- registros gubernamentales de salud a nivel nacional y municipal;
- repositorios de datos abiertos y observatorios estadísticos.

Los indicadores relevados permitieron comparar dimensiones clave como:

- número de centros de APS por habitante,
- proporción de profesionales médicos y de enfermería en el primer nivel,
- volumen de consultas per cápita,
- tiempos aproximados de espera para turnos y derivaciones,
- mecanismos de registro poblacional y cobertura efectiva,
- atención a personas migrantes con distintos grados de documentación.

Técnicas de sistematización

Como herramienta central se empleó la comparación estructurada. Para ello se construyó un cuadro comparativo de doble entrada, en el cual se consolidó la información recogida para cada ciudad según las categorías analíticas definidas. Este cuadro funcionó como matriz de análisis y permitió identificar patrones, divergencias, vacíos de información y potenciales relaciones entre variables.
Asimismo, el uso de categorías homogéneas facilitó el cotejo entre modelos muy diferentes en términos de financiamiento, organización institucional y trayectorias históricas

ESTADO DEL ARTE

El relevamiento bibliográfico realizado permitió reconstruir los principales antecedentes conceptuales, históricos y metodológicos vinculados a la Atención Primaria de la Salud (APS), así como las herramientas analíticas relevantes para su estudio comparativo en distintos contextos urbanos.
En primer lugar, se identificaron dos trabajos que ofrecieron un marco internacional fundamental para comprender la génesis y evolución del concepto de APS. El artículo publicado en *Revista Hospitalaria*, "Antecedentes de la atención primaria en salud en el mundo", describió el desarrollo histórico de la APS desde experiencias tempranas de salud comunitaria, pasando por la Conferencia de Bandung (1937), hasta la Conferencia de Alma-Ata (1978), hito que consolidó la APS como estrategia global basada en la equidad, la participación social y la justicia sanitaria. A su vez, el artículo "Atención primaria de salud: una mirada global para orientarnos en lo local", publicado en SciELO Colombia (2021), presentó una revisión conceptual que articula la APS con valores contemporáneos de los sistemas de salud: territorialidad, enfoque comunitario, integralidad y orientación preventiva. Ambos trabajos permitieron situar la APS como un enfoque multisectorial y dinámico, con

capacidad para adaptarse a diferentes realidades socioeconómicas.

De manera complementaria, diversos documentos de organismos internacionales y gobiernos nacionales ofrecieron definiciones operativas y marcos metodológicos para el análisis de la APS. La "Guía de Estudio: Introducción a la Atención Primaria de Salud" (Gobierno de México, 2023) sistematizó los principios y funciones esenciales de la APS, destacando su centralidad para la equidad y la eficiencia en sistemas públicos. Por su parte, el documento de la OPS, "La Atención Primaria de Salud: una perspectiva internacional" (2007), aportó un marco comparativo que recuperó experiencias de distintos países y reforzó la relevancia de la APS como estrategia integradora capaz de articular niveles de atención, equipos de salud y determinantes sociales.

Entre las referencias teóricas centrales se destacó el libro de Bárbara Starfield, *Atención Primaria: equilibrio entre necesidades de salud, servicios y tecnologías* (2004). Esta obra, ampliamente reconocida como pilar conceptual en la materia, presentó evidencia robusta sobre la relación entre sistemas orientados a la APS y mejores resultados sanitarios, costos más eficientes y mayor equidad. Starfield definió la APS a partir de cuatro funciones esenciales —primer contacto, longitudinalidad, integralidad y coordinación— y ofreció un conjunto de indicadores que resultaron fundamentales para encuadrar comparaciones internacionales. Su aporte metodológico fue especialmente relevante para este trabajo, ya que ofreció criterios estandarizados para evaluar la fortaleza de la APS en distintos sistemas sanitarios.

A nivel local, el texto *Un Plan de Salud basado en la estrategia de Atención Primaria* de Gabriel Battistella (s/f) resultó clave para comprender el proceso de transformación del sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires. El autor reconstruyó el desarrollo histórico de la APS en la ciudad, analizó las limitaciones del modelo hospitalocéntrico y propuso la organización de redes integradas de cuidados progresivos. Asimismo, articuló estas reformas con compromisos internacionales, como Alma-Ata y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, destacando la importancia de la territorialización, la participación comunitaria y la articulación intersectorial.

Dentro de los antecedentes empíricos más relevantes, se analizó el trabajo de Maceira (s/f), "Propuesta de evaluación de estrategias de Atención Primaria en Salud. Una aplicación al caso de la Ciudad de Buenos Aires". Este estudio propuso un marco teórico-metodológico para evaluar la efectividad de los CESAC porteños, integrando variables institucionales y socioeconómicas. Sus hallazgos mostraron que los recursos disponibles incidieron significativamente en el desempeño de los centros, que el nivel educativo de la población

afectó la utilización efectiva de los servicios y que existió un fenómeno de autofocalización, mediante el cual los centros tendieron a atender a sectores con mayores niveles de pobreza. El trabajo aportó evidencia valiosa para pensar la relación entre eficiencia, equidad y organización territorial en la APS local.

Otros aportes conceptuales provinieron del artículo de Vignolo et al. (2011), "Niveles de atención, de prevención y atención primaria de la salud", donde se clarificaron las diferencias entre niveles de atención según complejidad y se ofreció un marco conceptual útil para la planificación sanitaria y la evaluación comparativa. Su aporte metodológico resultó fundamental para ordenar la comprensión de la articulación entre niveles en los modelos analizados.

Por último, el trabajo de Puig-Junoy (2000), "Eficiencia en la Atención Primaria de Salud: una revisión crítica de las medidas de frontera", permitió abordar la dimensión económica de la APS desde una perspectiva analítica. A través de la revisión de doce estudios españoles que emplearon técnicas de análisis de frontera (DEA y otros modelos), el autor identificó limitaciones metodológicas frecuentes y destacó la necesidad de incorporar resultados de salud y variables contextuales en las evaluaciones de eficiencia. Su revisión contribuyó a problematizar la relación entre eficiencia administrativa, desempeño institucional y equidad en la APS.

MARCO TEÓRICO

En primer lugar, resultó de utilidad poder conceptualizar el término Atención Primaria de la Salud, o APS como lo hemos decidido denominarlo.

Tanto la OMS (2008) como la OPS (2007), la conciben como un enfoque de salud que incluye a toda la sociedad para garantizar el mayor nivel posible de salud y bienestar a la persona usuaria atendiéndola lo más pronto posible a lo largo del proceso continuo que va, desde la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, hasta el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos y tan próximo como sea posible del entorno cotidiano de las personas. Es decir que integra a la atención sanitaria junto a intervenciones comunitarias en un marco de equidad y participación social.

La OMS (2008) también adhiere que un sistema orientado por APS produce mejores resultados, mayor equidad y eficiencia mejorada.

En resumidas cuentas, la APS es el nivel fundamental de todo sistema de salud a fin de asegurar el acceso inicial, la continuidad en el tiempo y una atención completa a las personas.

Es un modelo de atención centrado en la persona usuaria, quien es ubicada en el centro del sistema, considerando sus necesidades, preferencias y contexto familiar/social. Esto implica un abordaje integral, respeto por la autonomía del usuario y participación en la toma de decisiones sobre su salud. La OMS (2008) señala que la APS debe entregarse de forma centrada en las necesidades de la gente y respetando sus preferencias.

Para Gabriel Battistella, la APS constituye mucho más que un nivel asistencial: se trata de una estrategia organizativa fundamental para transformar los sistemas de salud hacia modelos más equitativos, eficientes y centrados en las personas. En su propuesta para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Battistella sostiene que la APS debe concebirse como un enfoque integral que articula territorialización, participación comunitaria y coordinación entre niveles de atención. Según el autor, "la Atención Primaria de la Salud debe ser entendida como una estrategia integral que organiza el sistema sanitario a partir de las necesidades de la población, promoviendo el acceso equitativo, la continuidad del cuidado, la participación comunitaria y la articulación intersectorial" (Battistella, s/f, p. 2).

Según el autor, la salud también abarca otros ámbitos, como el ocio, el trabajo, educación, esparcimiento, deporte y diversión y, por lo tanto, en esta estrategia se piensa en una ciudad saludable. Bajo este concepto se elaboran nuevas tácticas y la intervención de los profesionales, tanto dentro como fuera de los efectores, tiene un perfil preventivo. A su vez, los equipos tienen horas destinadas a trabajar, no sólo en el centro de salud, sino también en la comunidad: trabajan con el club del barrio para que la gente que va a hacer gimnasia al club o juega venga a hacerse los controles de salud. Lo importante es poder trabajar en red para reforzar el cuidado y lo preventivo.

Esta definición pone el foco en el carácter estructurante de la APS y la aleja de una visión limitada a prácticas asistenciales básicas, subrayando su potencial como motor de transformación institucional y de justicia sanitaria.

En una línea similar, Barbara Starfield (2004) define la APS como el eje central de un sistema de salud efectivo, caracterizada por ser el primer punto de contacto, centrarse en la persona, no en la enfermedad, atender la mayoría de los problemas de salud comunes, y coordinar la atención en todos los niveles del sistema. Para ella, los sistemas con fuerte orientación hacia la atención primaria logran mejores resultados en salud, menor gasto global y mayor equidad. Ambos autores coinciden en que la APS no solo mejora los indicadores sanitarios, sino que también ofrece un marco organizativo y ético desde el cual repensar la relación entre Estado, comunidad y sistema de salud.

Este concepto nos derivó a desarrollar otro, que es el de patient pathway o itinerario

asistencial. Este concepto hace referencia al conjunto de pasos y servicios que recorre una persona desde el primer contacto sanitario hasta la resolución de su problema de salud. Incluye la identificación de síntomas, la consulta en APS, posibles derivaciones a niveles secundario o terciario, seguimientos y retorno a la APS. Un itinerario bien diseñado busca optimizar el flujo asistencial, evitar demoras innecesarias y asegurar continuidad de la atención. En la práctica, ello implica una coordinación eficiente entre los distintos niveles de atención y facilidades para el paciente. Mejorar la ruta o camino del paciente es un objetivo de la APS centrada en la comunidad.

Por su parte, también fue necesario definir el concepto de canasta básica de servicios de Atención Primaria de la Salud (APS). Se refiere al conjunto mínimo de prestaciones esenciales que deben estar disponibles para toda la población, especialmente en el primer nivel de atención, con criterios de equidad, integralidad y accesibilidad. La OMS (2008) ha señalado que estos servicios deben cubrir "la promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos, ofrecidos lo más cerca posible del entorno cotidiano de las personas".

Esta canasta suele incluir atenciones fundamentales como vacunación, salud materno-infantil, control de enfermedades transmisibles y no transmisibles, provisión de medicamentos esenciales y acciones de promoción de la salud. Según la OPS (2014), constituye una herramienta estratégica para avanzar hacia la cobertura universal de salud, porque permite planificar, priorizar recursos y garantizar un piso común de acceso a derechos.

Maceira (2005) sostienen que la definición de una canasta básica explícita mejora la transparencia del sistema sanitario, reduce la fragmentación y contribuye a la equidad, al establecer qué servicios deben ser provistos a todos los ciudadanos independientemente de su condición socioeconómica o jurisdicción territorial. En muchos países de América Latina, el establecimiento de canastas básicas de APS ha sido un componente central de las reformas sanitarias. Sin embargo, la definición formal de la canasta no garantiza su cumplimiento efectivo: factores como la escasez de recursos, la desigualdad entre regiones o la exclusión de poblaciones migrantes y rurales pueden limitar su implementación. Por ello, la canasta debe pensarse no solo como una lista técnica, sino como una expresión política del derecho a la salud, cuya realización concreta depende de la voluntad institucional y de la capacidad de gestión del sistema.

Un concepto importante para desarrollar en esta investigación fue el de acceso a la salud. El mismo fue abordado desde distintas perspectivas teóricas, donde se lo define como una dimensión central en la organización de los sistemas sanitarios y en el ejercicio efectivo del

derecho a la salud.

En líneas generales, el acceso puede entenderse como la posibilidad real que tienen las personas de utilizar servicios de salud en el momento que lo requieren, en condiciones de equidad, oportunidad, calidad y aceptabilidad.

Penchansky y Thomas (1981), conceptualizan el acceso como el grado de ajuste entre las características de los servicios de salud y las necesidades y expectativas de la población. Es así, que el acceso comprende cinco dimensiones: disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad, aceptabilidad y adecuación. Estos términos hacen referencia tanto a la oferta adecuada de recursos, como a la proximidad geográfica o facilidad de traslado, a que los costos que no representen una barrera, a que haya una compatibilidad cultural y trato digno y también a una organización del sistema que responda a las necesidades reales de los usuarios.

Por su parte, para Avedis Donabedian (1984), el acceso es también una condición estructural que determina la posibilidad de obtener atención médica de calidad, y debe ser evaluado en relación con los resultados en salud y la satisfacción de las personas. En esta línea, el acceso no se limita a la mera existencia de servicios, sino que implica su utilización efectiva y su impacto positivo sobre la salud.

Según Birgin y Gherardi (2011) el concepto de accesibilidad tiene una dimensión normativa, es decir, el derecho de hacer valer los derechos legalmente reconocidos para todos y todas las ciudadanas; y una dimensión fáctica: aquello relacionado a los procedimientos tendientes a asegurar que haya un acceso. Asimismo, afirman que es la posibilidad de que toda persona pueda tener acceso a una atención justa y a un servicio valedero, aún si no tiene los recursos económicos suficientes, y también asegurar el conocimiento, por parte de los ciudadanos, de sus derechos y de los medios para ejercerlos.

Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) se sostiene que el acceso universal a la salud significa que todas las personas y comunidades pueden utilizar los servicios de salud que necesitan sin sufrir dificultades financieras (OMS, 2010). En su informe de 2008, sobre atención primaria, remarcó que el acceso equitativo es un principio fundamental de los sistemas de salud orientados a la atención primaria.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) también desarrolló este concepto, entendiendo que implica no solo la existencia de servicios, sino también la eliminación de barreras geográficas, económicas, organizativas y culturales que impiden su utilización efectiva (OPS, 2014). De esta manera, garantizar el acceso requiere transformaciones estructurales en los sistemas de salud.

Finalmente, como plantea Daniel Maceira (2005), en el caso argentino la problemática del

acceso está íntimamente ligada a la fragmentación del sistema y a las desigualdades territoriales, sociales y económicas. Según el autor, mejorar el acceso implica repensar el financiamiento, la articulación institucional y la distribución de recursos, en pos de una mayor equidad.

El concepto de acceso a la salud nos llevó a pensar en otro, muy ligado, y actualmente importante, a las ciudades que tomamos como referencias: es el concepto de personas migrantes.

Las personas migrantes son, en palabras de Úrsula Santa Cruz Castillo, "sujetos políticos que actúan en espacios transnacionales" (2012:01) que deciden migrar, por diferentes motivos, a otros países. Muchas veces, creyendo en la búsqueda de mejorar la calidad de vida, terminan envueltos en situaciones que vulneran sus derechos humanos. Problemáticas como las consecuencias de la globalización, las pesadas deudas externas y crisis ambientales, son algunas de las razones por las cuales las personas deciden dejar su país para buscar una mejor situación económica. Principalmente, la creciente participación de las mujeres en los procesos migratorios internacionales registradas en las últimas décadas ha dado lugar a un fenómeno conocido como feminización de las migraciones.

En este contexto, el acceso a la salud se ve directamente condicionado por la situación migratoria de las personas, atravesada por desigualdades legales, económicas y culturales. Las personas migrantes —y en particular las mujeres— suelen enfrentar múltiples barreras para acceder a servicios de salud: desde la falta de documentación o cobertura, hasta la discriminación institucional o la ausencia de políticas con enfoque intercultural. Así, la migración no solo redefine las dinámicas demográficas y laborales en los territorios de destino, sino que también interpela al sistema de salud en su capacidad de garantizar derechos en condiciones de equidad y justicia social.

RESULTADOS Y ANÁLISIS COMPARATIVO

El análisis comparativo de los cuatro sistemas urbanos —São Paulo, CABA, Madrid y Londres— permitió reconstruir cómo se configuraron sus estrategias de Atención Primaria de la Salud (APS) y qué lugar ocuparon dentro de sus modelos sanitarios. La lectura integrada de las dimensiones definidas en la metodología posibilitó identificar patrones estructurales, tensiones persistentes y decisiones políticas que condicionaron, en cada caso, las posibilidades de garantizar el derecho al acceso a la salud.

1. Contexto y población atendida

Los cuatro sistemas compartieron el rasgo común de estar insertos en grandes conglomerados urbanos, atravesados por desigualdades socioeconómicas históricas y dinámicas migratorias intensas. No obstante, cada ciudad operó sobre bases demográficas diferentes.

São Paulo se caracterizó por ser el territorio más extenso y demográficamente complejo, con marcadas heterogeneidades internas que se reflejaron en demandas asistenciales divergentes entre distritos. En Londres, la multiculturalidad fue un componente estructural del sistema, impulsada por flujos migratorios sostenidos y una movilidad interna alta, que exigió mecanismos de registro poblacional eficientes y sensibles a la diversidad cultural. Madrid presentó una proporción elevada de adultos mayores, lo que impactó en la organización de la atención y en la frecuencia de consultas por enfermedades crónicas. CABA, en cambio, mostró una particularidad: aunque su población residente era menor que la de las otras ciudades, el sistema público absorbió una demanda extraterritorial significativa —proveniente del conurbano bonaerense—, lo que dificultó la estimación exacta de su población efectiva usuaria.

Los factores socioambientales también delimitaron las necesidades de salud. São Paulo presentó desafíos asociados a desigualdades barriales profundas, servicios básicos insuficientes en algunos sectores y una carga elevada de enfermedades crónicas vinculadas a determinantes sociales. CABA evidenció contrastes entre zonas de mayor y menor vulnerabilidad, en muchos casos asociados a la precariedad habitacional. Madrid enfrentó desigualdades territoriales crecientes entre distritos, mientras que Londres mostró contrastes definidos entre boroughs con altos niveles de privación social y otros con mejores indicadores.

La población migrante ocupó un lugar central en todas las experiencias, aunque con políticas diferenciadas. São Paulo ofreció una admisión amplia sin requisitos documentales estrictos; Londres se basó en criterios de residencia y registración; Madrid atravesó cambios normativos que introdujeron barreras fluctuantes; y CABA atendió de manera universal, pero sin registros capaces de dimensionar con precisión la demanda migrante. Esta situación complejizó especialmente la planificación del sistema porteño.

2. Recursos y organización del sistema

Las diferencias en disponibilidad y organización de recursos revelaron tres modelos predominantes: los sistemas territorializados y con adscripción poblacional formal (São Paulo

y Londres), los sistemas que buscaron combinar cercanía territorial con prestaciones hospitalarias de referencia (Madrid), y los modelos con fuerte peso hospitalario y un primer nivel fragmentado (CABA).

En términos de infraestructura, São Paulo y Londres mostraron la mayor densidad de centros orientados específicamente a la APS. La "Estrategia Saúde da Família" en Brasil desplegó equipos responsables de territorios definidos, integrando atención domiciliaria, actividades comunitarias y seguimiento clínico. Londres, por su parte, consolidó un modelo basado en *general practitioners* (GPs), donde cada paciente se inscribía en un consultorio responsable de coordinar su atención.

Madrid contó con una red establecida de centros de salud con equipos multiprofesionales, aunque afectados en los últimos años por tensiones presupuestarias y una demanda creciente. En CABA, los Centros de Salud y Acción Comunitaria mostraron avances en cobertura territorial, pero persistió la fragmentación entre CESAC y hospitales, con una distribución desigual en barrios de alta vulnerabilidad.

Respecto de los recursos humanos, Londres y São Paulo se destacaron por la estabilidad de sus equipos y por la formación específica en medicina general o medicina de familia. CABA presentó un déficit histórico de profesionales del primer nivel, lo que obligó a equipos reducidos a asumir demandas crecientes. Madrid enfrentó situaciones de sobrecarga laboral y rotación de personal, especialmente después de la pandemia, lo que afectó la continuidad del cuidado.

La canasta básica de servicios mostró variabilidad. Londres ofreció un espectro amplio de prestaciones, con énfasis en prevención y longitudinalidad. São Paulo integró actividades de salud comunitaria y atención clínica básica. Madrid y CABA garantizaban servicios esenciales, aunque con profundidades distintas según disponibilidad local, presupuesto y organización interna.

Los sistemas de información constituyeron otra dimensión diferenciadora. Londres presentó uno de los modelos más integrados, con historiales clínicos digitales interoperables. São Paulo avanzó en la digitalización mediante sistemas como e-SUS, permitiendo seguimiento poblacional detallado. Madrid y CABA mostraron avances desiguales: coexistieron plataformas modernas con sistemas parciales, y la interoperabilidad fue una deuda persistente.

Finalmente, el análisis presupuestario reflejó diferencias claras. Londres y São Paulo invirtieron de manera más sostenida en APS dentro de sus sistemas nacionales. Madrid y

CABA operaron bajo restricciones recurrentes, lo que limitó la expansión de servicios y la incorporación de recursos humanos.

3. Acceso y desempeño de la APS

Las condiciones de acceso revelaron heterogeneidades marcadas entre ciudades. São Paulo y Londres ofrecieron modelos más estructurados, donde la adscripción poblacional facilitó el seguimiento y la planificación. En contraste, CABA y Madrid mantuvieron barreras administrativas intermitentes, disponibilidad irregular de turnos y dificultades para garantizar el acceso por proximidad territorial en algunos sectores.

La accesibilidad geográfica en São Paulo estuvo favorecida por el despliegue territorial de la APS, aun con desigualdades entre distritos más periféricos. Londres presentó buena distribución, aunque con saturación en algunos consultorios. Madrid mostró disparidades entre áreas metropolitanas y zonas periféricas. CABA evidenció desequilibrios entre comunas con mayor presencia de CESAC y otras que dependieron en gran medida de hospitales.

En cuanto a los tiempos de espera, Londres destacó por demoras significativas en turnos programados, un problema históricamente señalado del NHS. Madrid también registró demoras importantes, especialmente en medicina general. CABA presentó tiempos variables según centro y especialidad, mientras que São Paulo mostró esperas moderadas con variabilidad distrital.

El recorrido del paciente difería sustancialmente. Londres funcionó bajo un modelo de puerta de entrada obligatoria a través del GP, quien coordinaba toda la atención posterior. São Paulo articuló derivaciones desde los equipos territoriales, privilegiando la continuidad del cuidado. Madrid mantuvo un sistema de referencia y contrarreferencia formal pero con dificultades operativas. CABA mostró un modelo híbrido, donde la población podía ingresar tanto por el primer nivel como por los hospitales sin una regulación homogénea.

La gratuidad de la APS fue una constante en las cuatro ciudades, aunque con distintos matices administrativos. Las personas migrantes encontraron barreras específicas en Madrid y parcialmente en Londres, mientras que São Paulo y CABA mantuvieron accesos más amplios, aunque en este último caso con limitaciones en su registro poblacional.

En conjunto, los resultados permitieron observar que los sistemas de APS con mayor

articulación territorial, recursos humanos estables y adscripción poblacional clara tendieron a mostrar mejores niveles de eficacia, tanto en acceso como en continuidad del cuidado. São Paulo y Londres se ubicaron en este grupo, aun con problemas estructurales propios de ciudades densamente pobladas.

CABA y Madrid evidenciaron avances importantes, pero mantuvieron desafíos significativos vinculados a restricciones presupuestarias, desigualdades territoriales y falta de homogeneidad en el uso del primer nivel de atención. La fragmentación institucional dificultó, en ambos casos, convertir la APS en una verdadera puerta de entrada preferente.

A pesar de las diferencias, las cuatro ciudades compartieron un consenso fundamental: la APS continuó siendo la herramienta más sólida para ampliar derechos, reducir inequidades sanitarias y ordenar la creciente complejidad de los sistemas urbanos contemporáneos.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Esta investigación permitió identificar patrones comunes, divergencias estructurales y tensiones persistentes en torno al acceso a la salud y al rol que cada ciudad otorgó al primer nivel de atención. En las cuatro experiencias, la APS se consolidó como un componente central para garantizar el derecho a la salud; sin embargo, el modo en que este principio se tradujo en políticas concretas dependió de la capacidad de cada sistema para articular territorio, recursos y gestión con las necesidades reales de sus poblaciones.

En las ciudades donde existió una red territorial amplia, equipos interdisciplinarios sostenidos y una adscripción poblacional clara —como São Paulo y, en buena medida, Londres—, la APS mostró una mayor coherencia interna y una mejor capacidad resolutiva. Allí donde los sistemas operaron con restricciones presupuestarias, fragmentación administrativa o escasez de personal especializado —como CABA y Madrid—, el acceso efectivo se vio condicionado por tiempos de espera prolongados, recorridos asistenciales poco homogéneos y desigualdades territoriales persistentes.

Las diferencias observadas entre ciudades mostraron que la equidad en el acceso no dependió únicamente del volumen de recursos disponibles, sino de la forma en que los sistemas organizaron su estructura de APS. El análisis evidenció que los modelos centrados en una estrategia comunitaria, con fuerte presencia territorial y mecanismos claros de coordinación, tendieron a generar una mayor cercanía con la población, una mejor identificación de necesidades locales y una reducción de brechas de acceso. Por el contrario, los modelos

orientados predominantemente hacia la eficiencia administrativa o la contención del gasto lograron mejoras puntuales, pero no redujeron necesariamente las desigualdades.
Desde esta perspectiva, se desprendieron una serie de recomendaciones que podrían orientar futuros desarrollos de la estrategia de APS:

1. Fortalecer la territorialidad y la adscripción poblacional

La experiencia de São Paulo mostró que los equipos de salud asignados a territorios definidos, con conocimiento directo de las condiciones sociales de sus comunidades, incrementaron la capacidad de respuesta y mejoraron la continuidad del cuidado. La adscripción efectiva permitió planificar, priorizar y evaluar de manera sistemática.

2. Reforzar los recursos humanos especializados

En varias ciudades, en particular CABA y Madrid, la carencia de médicos generalistas y de familia limitó la resolutividad del primer nivel. La formación, retención y estabilidad de estos profesionales resultó indispensable para asegurar la continuidad del cuidado y disminuir las derivaciones innecesarias.

3. Integrar los sistemas de información

Los sistemas más robustos fueron aquellos que lograron unificar registros, historiales clínicos y flujos de derivación. La interoperabilidad no solo mejoró la gestión clínica, sino que permitió evaluar con mayor precisión resultados y necesidades.

4. Asegurar financiamiento sostenido y proporcional a las necesidades sociales

La comparación mostró que el financiamiento insuficiente tendió a profundizar desigualdades territoriales y a sobrecargar la demanda hospitalaria. Invertir en APS implica, en términos de política pública, reducir gastos hospitalarios futuros y mejorar indicadores de salud poblacional.

5. Incorporar un enfoque sensible a la diversidad cultural y migratoria

Las cuatro ciudades recibieron población migrante, pero con respuestas institucionales desiguales. La atención sin barreras documentales, acompañada de políticas lingüísticas y

culturales adecuadas, mejoró no solo el acceso, sino también la confianza de la población en el sistema.

6. Reducir los tiempos de espera y simplificar la accesibilidad administrativa

Una APS eficaz requiere que la puerta de entrada sea fluida. Turnos oportunos, modalidades de atención combinadas (presencial, telefónica y digital) y procedimientos administrativos simples demostraron impacto en la utilización efectiva de los servicios.

7. Reafirmar el rol de la APS en la agenda de salud y en los compromisos internacionales

En el caso particular de la Ciudad de CABA, fortalecer la APS no solo responde a necesidades locales sino también a compromisos asumidos en materia de desarrollo sostenible, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, especialmente aquellos vinculados a la salud, las desigualdades y la inclusión urbana.

BIBLIOGRAFÍA

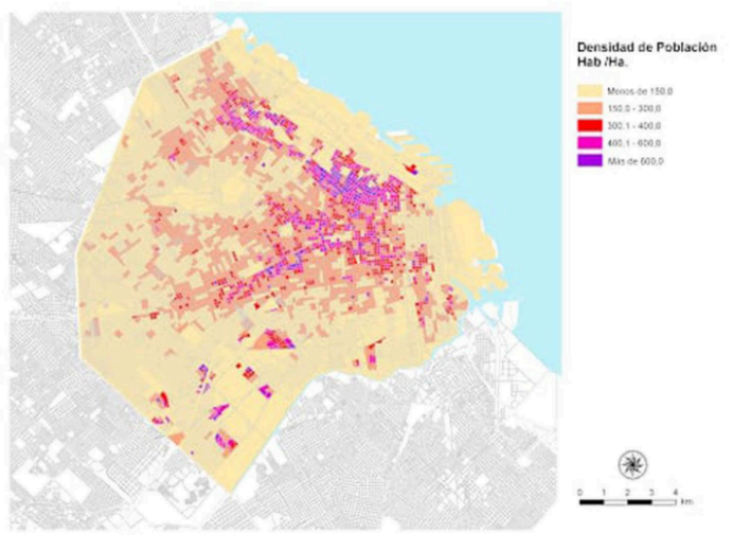
- S/D "Antecedentes de la atención primaria en salud en el mundo" Revista hospitalaria (2024). Link: https://revistahospitalaria.org/enportada/antecedentes-de-la-atencion-primaria-en-salud-en-el-mundo/
- Battistella , G. (S/F) "Un Plan de Salud Basado en la estrategia de Atención Primaria". Material de cátedra del Departamento de Medicina Familiar. UBA.
- Birgin, Haydée y Gherardi, Natalia (2011) “Introducción” en Acceso a la Justicia. Aportes empíricos y conceptuales. México, Fontamara.
- Calderón Gómez, C. y Betancurth Loaiza, D. (2021) "Atención primaria de salud: una mirada global para orientarnos en lo local" Rev. Salud pública vol.23 no.5 Bogotá Sep./Oct.
- Cyment, Paola y Pombo, Gabriela (2018) “Acceso a la justicia de las mujeres migrantes en situación de violencia doméstica” en Cerrando brechas para erradicar la violencia contra las mujeres. Aportes para fortalecer una agenda integral para la igualdad de género. Cord. Natalia Gherardi. Buenos aires, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).
- Donabedian, A. (1984) “Explorations in quality assessment and monitoring”. Volume III: The methods and findings of quality assessment and monitoring. Ann Arbor: Health Administration Press.
- García Latorre, J. F., Marcuello Servos, C., Serrano Peris, G., Pérez, O. (1996) “Evaluación de la eficiencia en centros de atención primaria. Una aplicación del análisis envolvente de datos”. Revista de Salud Pública; 70:211-220.
- Gobierno de México (2023) “La Guía de Estudio: Introducción a la Atención Primaria de Salud”
- Maceira, D. (2005) “Descentralización y Equidad en el Sistema de Salud Argentino”, en Flood, C., La política del gasto social: lecciones de la experiencia argentina, Editorial La Colmena, Buenos Aires.
- Maceira, D. (S/F) "Propuesta de evaluación de estrategias de Atención Primaria en Salud. Una aplicación al caso de la Ciudad de Buenos Aires" CEDES. Link: https://repositorio.cedes.org/bitstream/123456789/3675/1/6863.pdf
- Ministerio de Salud Gobierno de Ciudad de Buenos Aires, Atención Primaria de la Salud, Anuario 2004/2005.

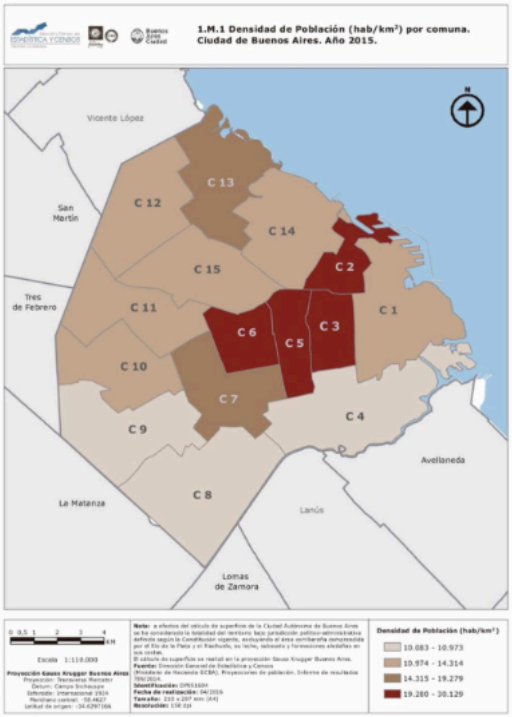
- Ministerio de Salud Gobierno de Ciudad de Buenos Aires, “Sistema de Información de Atención Primaria de la Salud. Subsistema CESAC (SICESAC). Instructivos y definiciones. Versión 4”. Dirección de Estadísticas para la salud. Departamento de Análisis Estadístico.
- Organización Mundial de la Salud (OMS). (2008). “La atención primaria de salud: más necesaria que nunca. Informe sobre la salud en el mundo”. Ginebra.
- Organización Mundial de la Salud (OMS). (2010). “Cobertura universal de salud”. Ginebra.
- Organización Panamericana de la Salud (OPS) (2007), “La Atención Primaria de Salud: una perspectiva internacional”
- Organización Panamericana de la Salud (OPS). (2014). “Estrategia para el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud”. Washington, D.C.
- Penchansky, R., & Thomas, J. W. (1981). “The concept of access: definition and relationship to consumer satisfaction”. Medical Care, 19(2), 127–140.
- Pinillos, M., Antoñanzas, F. (2002) “La Atención Primaria de Salud: descentralización y eficiencia”. Gaceta Sanitaria, 16(5): 401-407.
- Puig-Junoy, J. (2000) “Eficiencia en la Atención primaria de salud: una revisión crítica de las medidas de frontera”. Revista de Salud Pública; 74:483-495.
- Santa Cruz Castillo, Úrsula (2012), “Participación, empoderamiento y política” Comunicación: invisibilidad, activismo y práctica política transnacional. Ponencia presentada en: Congreso Internacional FEMIGRA Feminismo y migración. Intervención social y acción política. Barcelona.
- Secretaría de Salud Gobierno de Ciudad de Buenos Aires, “Análisis de Situación de Salud (ASIS) de la población de la ciudad de Buenos Aires- Año 2003” Departamento de Epidemiología, Dirección General Adjunta de APS, 2004.
- Starfield B. (2004) “Atención Primaria: Equilibrio entre necesidades de salud, servicios y tecnologías”. Madrid: Masson.
- Vignolo, J., Vacarezza, M., Álvarez, C. y Sosa, A. (2011) "Niveles de atención, de prevención y atención primaria de la salud" en Archivos de Medicina Interna 33(1): 7–11. Link: http://scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-423X2011000100003
- Villalbi JR, Pasarin M, Montaner I, Cabezas C, Starfield B. (2003) “Evaluación de la atención primaria de salud”. Atención Primaria; 31: 382-5

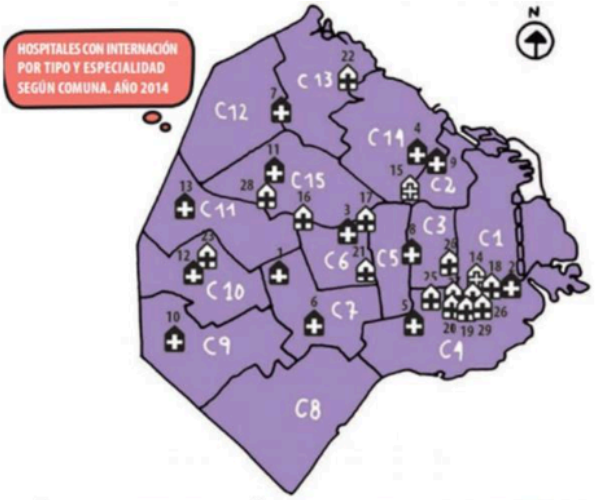
ANEXOS

ANEXO I

Mapeo de la Ciudad de Buenos Aires:







Hospital General de Agudos

1 Álvarez
2 Argerich
3 Durand
4 Fernández
5 Penna
6 Piñero
7 Pirovano
8 Ramos Mejía
9 Rivadavia
10 Santojanni
11 Tornú
12 Vélez Sársfield
13 Zubizarreta

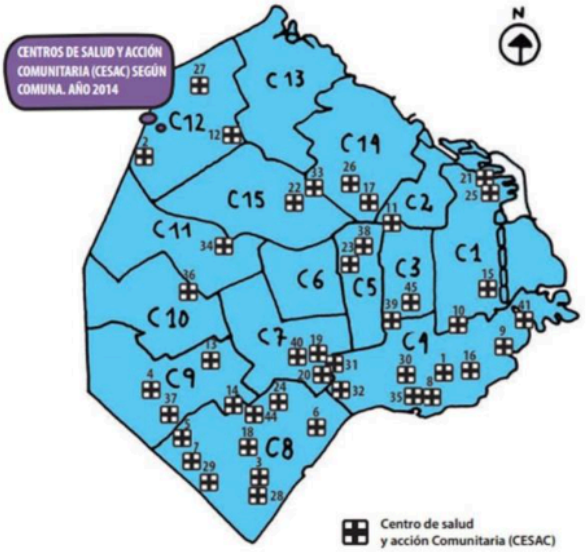
Hospital Especializado

14 Alvear (Salud mental)
15 Borda (Salud mental)
16 Lagleyze (Oftalmología)
17 María Curie (Oncología)
18 María Ferrer (Rehabilitación respiratoria)
19 Moyano (Salud mental)
20 Muñiz (Infectología)
21 Quemados (Quemados)
22 Rehabilitación Psicofísica (Medicina física/Rehabilitación)
23 Rocca (Medicina física/ Rehabilitación)
24 Santa Lucía (Oftalmología)
25 Sardá (Materno-Infantil)
26 Tobar García (Salud mental)
27 Udaondo (Enfermedades del aparato digestivo)

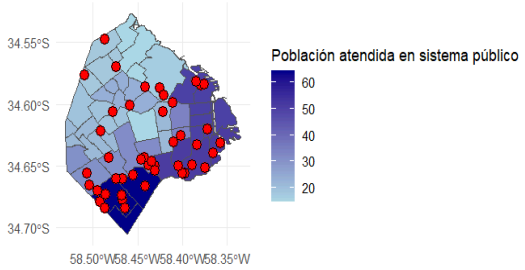
Hospital General de Niños

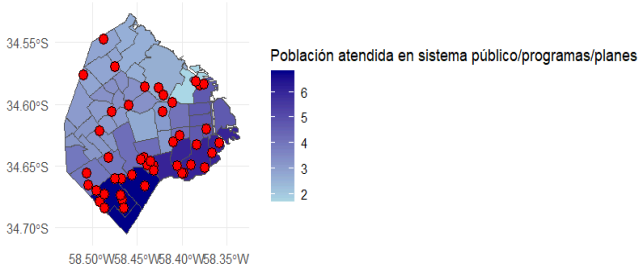
28 Elizalde (Pediatría)
29 Gutiérrez (Pediatría)

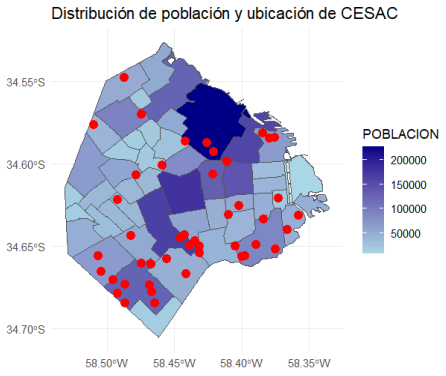
35

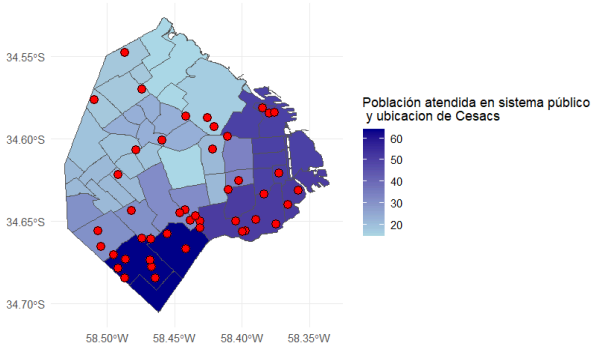


34


34.55°S
34.60°S
34.65°S
34.70°S
58.50°W58.45°W58.40°W58.35°W
Población atendida en sistema público
60
50
40
30
20


34.55°S
34.60°S
34.65°S
34.70°S
58.50°W58.45°W58.40°W58.35°W
Población atendida en sistema público/programas/planes
6
5
4
3
2


Distribución de población y ubicación de CESAC
34.55°S
34.60°S
34.65°S
34.70°S
58.50°W
58.45°W
58.40°W
58.35°W
POBLACION
200000
150000
100000
50000


34.55°S
34.60°S
34.65°S
34.70°S
58.50°W
58.45°W
58.40°W
58.35°W
Población atendida en sistema público
y ubicacion de Cesacs
60
50
40
30
20

ANEXO II

El siguiente cuadro sistematiza la información comparativa de los modelos de Atención Primaria de la Salud en cuatro ciudades (CABA, São Paulo, Madrid y Londres). Para facilitar el análisis, los datos se organizaron en tres grandes categorías: Contexto y población atendida, que reúne las características sociales y demográficas relevantes; Recursos y organización del sistema, que agrupa los aspectos vinculados a la infraestructura, los recursos humanos y la gestión; y Acceso y desempeño de la APS, que permite observar la interacción de la población con los servicios y la efectividad de la atención.

A. Contexto y población atendida: incluye las características demográficas y sociales de la población objetivo, así como factores que influyen en sus necesidades de salud.

	GCABA	MADRID	SAN PABLO	LONDRES
Cantidad de población	3.1 millones de habitantes	3.527.924 de personas.	12,4 millones de habitantes	9.840.740 habitantes.
Tipo de población para atención APS	Domiciliados en CABA, con cobertura pública exclusiva.	Residentes con tarjeta sanitaria	Universal para ciudadanos brasileños	Residentes, Ciudadanos con tarjeta europea.
Factores socioambientales	Se prioriza la intervención en villas y barrios populares. Se tuvieron en cuenta para la ubicación de los centros de salud: la mayoría al sur de Av. Rivadavia.	Se reconoce el impacto de determinantes sociales en la salud y se incluyen acciones de intervención comunitaria. Se destacan programas de atención domiciliaria, abordaje del aislamiento social y coordinación	Contaminación atmosférica grave en zonas industriales (Guaianases, Citadentes). Altas tasas de violencia, homicidios y mortalidad por causas externas. Alta prevalencia de problemas respiratorios y consumo de drogas en población infantil en	

		con servicios sociales.	situación de calle.	
Inmigrantes	La ciudad garantiza el acceso a la salud para todas las personas, independientemente de su situación migratoria. Sin documentos: solo emergencias	La atención sanitaria se brinda independientemente de la situación administrativa, incluyendo a población migrante sin papeles. Se desarrollan estrategias de acceso universal, aunque en la práctica pueden presentarse barreras burocráticas o idiomáticas.	Alta movilidad urbana y asentamientos informales impactan en la planificación.	Sin documentos y de países extra CE : solo emergencias. UE: acceso igual que ciudadanos británicos con tarjeta sanitaria. Fuera de la UE o indocumentados : solo derecho a atención de urgencia en hospitales.

B. Recursos y organización del sistema: agrupa todo lo relacionado con la infraestructura, recursos humanos, modelo de gestión y organización de los servicios.

	GCABA	MADRID	SAN PABLO	LONDRES
Distribución y cantidad de efectores de salud (recursos físicos)	50 CESAC, 2 CEMAR, 35 hospitales	262 Centros de Salud (CS), 168 Consultorios Locales (CL). Además, se registran 55 Unidades de Apoyo y 16 dispositivos de Atención Continuada.	15 hospitales 12 servicios de urgencia (pronto socorro) 45 centros de atención primaria 403 Unidades Básicas de Salud (UBS) 23 ambulatorios de especialidades 4 laboratorios	Existen centros de salud (CS), walk-in centres (sin cita), NHS Direct (consultas telefónicas) y centros de atención continuada.

			30 unidades AMA (Atendimento Médico Ambulatorial)	
Cantidad de profesionales médicos APS	Especialistas **50,59%** , APS sobre especialistas **26,21%**	4.033 médicos de familia 2.255 pediatras 5.226 enfermeros/as	1 médico, 1 enfermera, 1 auxiliar de enfermería y 4 a 6 agentes comunitarios de salud, responsables por hasta 1.000 familias. En 2006 había 934 equipos PSF y 62 equipos PACS (Programa de Agentes Comunitarios de Salud).	40.279 GPs (~2–2,7 por cada 1.000 habitantes). Los GPs se asocian para formar equipos y contratar personal complementario según necesidades locales.
Organización por niveles de complejidad	Primer nivel de atención (CeSACs) Segundo nivel: hospitales generales y especializados Gestión en positivo, acceso a medicación gratuita en los CESAC.	La Atención Primaria funciona como puerta de entrada al sistema y coordina con atención hospitalaria y especializada. La estrategia apunta a reforzar el rol resolutivo del primer nivel y a mejorar la coordinación asistencial.	Atención estructurada desde las UBS (atención primaria) hasta hospitales y pronto socorro. Las AMA y otros efectores brindan atención intermedia. El sistema tiene dificultades de articulación entre niveles en algunas zonas.	La APS es el primer nivel de contacto obligatorio (función de gatekeeper). Los GPs derivan a especialistas mediante el sistema “choose and book”.

Canasta básica de atención	Control de salud integral (niños, adultos, embarazadas, adultos mayores) Vacunación, salud mental comunitaria, planificación familiar Enfermería, salud bucal, nutrición y trabajo social Se trabaja en prevención, promoción, seguimiento de enfermedades crónicas y cuidados domiciliarios. Consultas generales,especialistas, vacunacion, Odontologia, estudios de diagnostico Rx.	Prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de patologías agudas y crónicas. Vacunación, salud sexual y reproductiva, salud infantil y del adulto mayor. Salud mental básica, cuidados paliativos, educación sanitaria y promoción de la salud.	Salud infantil, de la mujer y del adulto mayor. Enfermedades prevalentes: hipertensión, diabetes, tuberculosis, hanseniasis. Salud bucal, vacunación, atención prenatal, promoción de la salud. Atención comunitaria e interdisciplinaria.	Cartera de servicios similar a España, aunque con restricciones en tecnología y medicamentos, reguladas por el NICE (National Institute for Health and Care Excellence). Atención ginecológica y pediátrica está integrada en APS.
Sistemas de información	Historia Clínica Electrónica Integral (HCEI) y un sistema de turnos digital único para toda la red pública.	Plataforma AP Madrid, un sistema informatizado que unifica la historia clínica electrónica y permite el seguimiento del paciente en todos los niveles.	En desarrollo: DataSUS busca integrar datos de atención primaria, urgencias, especialidades y hospitales.	Historia clínica completamente informatizada desde el año 2000. Softwares como EMIS o VISION permiten codificación y acceso ágil. Conservación obligatoria por 30 años.

Presupuesto	El área de salud representa aproximadamente el 18% del presupuesto total del GCBA. En 2023, el programa de APS tuvo una asignación superior a 40 mil millones de pesos, incluyendo infraestructura, personal y equipamiento.	En 2023, el presupuesto ejecutado de Atención Primaria fue de 1.700 millones de euros, lo que representa un aumento del 6,8% respecto al año anterior. El presupuesto se distribuyó en las siguientes áreas: Personal: representa más del 70% del gasto total, debido a la incorporación de nuevos profesionales y mejoras salariales. Infraestructura y equipamiento: se destinaron más de 56 millones de euros a obras, ampliaciones y renovación tecnológica en centros de salud. Transformación digital y sistemas de información: más de 16 millones de euros invertidos en modernización del sistema AP-Madrid y conectividad. La inversión por	Sin datos	En 2008, el gasto público en salud fue del 8,7% del PBI. Los CS reciben una suma anual basada en: número de pacientes condiciones socioeconómicas cumplimiento de metas del Quality Outcomes Framework El sueldo de los GPs puede oscilar entre £50.000–£120.000 anuales.

		habitante asignado en Atención Primaria se estima en alrededor de 248 euros anuales		

C. Acceso y desempeño de la APS: reúne las variables que muestran cómo la población interactúa con el sistema y qué tan efectiva es la atención.

	GCABA	MADRID	SAN PABLO	LONDRES
Accesibilidad administrativa	Requiere DNI o domicilio en CABA para empadronamiento que se realiza en centros de salud . Turnos por sistema online ,telefonico o presencial. Limitado cambio de médico o centro.	Empadronamiento en centro de salud. Turnos por web o teléfono. Puede haber demoras en cambios.	Tarjet SUS , con documento de identidad brasilero ,que se expide en algun Posto de Saúde, en la Secretaría Municipal de Saúde, o en algún otro centro de salud.	Registro obligatorio en GP. Cambio de GP posible, pero no inmediato. Turnos online y por app.
Accesibilidad geográfica	La política sanitaria promueve la territorialización de la salud, con equipos distribuidos según las necesidades demográficas y sociales de cada barrio. Se prioriza el acceso cercano y el trabajo barrial, aunque	"Proximidad y distribución territorial equilibrada" que permite a los usuarios acceder a un centro de salud cerca de su residencia habitual. La mayoría de los ciudadanos tiene un centro asignado a menos de 15 minutos a pie,	El modelo está basado en microáreas de cobertura: cada equipo PSF atiende entre 800 a 1.000 familias, con presencia en más del 86% de los municipios brasileños. Persisten grandes desigualdades de acceso entre	El paciente puede elegir el centro de salud. Existen incentivos para atender poblaciones complejas (zonas rurales, marginales o con pacientes con adicciones).

	existen desigualdades persistentes entre zonas norte y sur.	aunque en zonas rurales se mantienen consultorios con horarios reducidos para garantizar cobertura.	barrios centrales y periféricos (ej. Jardim Ângela).	
Recorrido del paciente	El ingreso puede ser también a través del equipo de salud territorial del CeSAC, que coordina derivaciones, seguimientos y visitas domiciliarias. Se impulsa la asignación de médico y enfermero de cabecera, con una lógica de acompañamiento longitudinal.	El paciente entra por el médico de cabecera o pediatra, quien deriva si es necesario a especialistas o servicios hospitalarios. Se trabaja para que el seguimiento de enfermedades crónicas y cuidados frecuentes se resuelvan dentro del ámbito de la Atención Primaria.	Modelo centrado en las UBS y el PSF como puerta de entrada. Derivación a niveles de mayor complejidad según necesidad. Se reportan dificultades para seguimiento de casos complejos y problemas de coordinación interinstitucional.	Inscripción obligatoria en un CS para acceder a todos los servicios (incluso no sanitarios). Derivación a especialistas mediante carta del GP ((similar al medico de Ap) es una figura mas amplia). Acceso a urgencias puede estar restringido y derivado nuevamente al GP.
Tiempos de espera (aprox)	No se publica un indicador unificado.	El 78,9% de los pacientes fueron atendidos por su médico de familia en menos de 48 horas desde la solicitud. Para enfermería, la cifra asciende al 84,7% en menos de 24 horas.	No se publica un indicador unificado.	Listas de espera.
Gratuidad	Si para domiciliados en	El sistema de salud público	Toda la atención provista por el	Si Totalmente

	CABA.	madrileño garantiza el acceso gratuito a la atención primaria, financiado por impuestos generales. Algunos medicamentos y prestaciones específicas pueden tener copagos, especialmente en población adulta.	SUS y el PSF es gratuita, como parte del derecho universal a la salud en Brasil.	gratuita en el punto de atención. Financiamiento por impuestos generales (83% del gasto sanitario). No hay un impuesto ni presupuesto específico para APS, pero sí asignaciones por capacitación.